DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: FAIBER OSPINA ROMAN **Identificación** CC 16341202
Edad: 77 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**441302**	**ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**	AMI	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

1	**452305**	**COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**	ANK	

Cirujano: JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES152 JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
452305 **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

Dx Postoperatorio: K296 OTRAS GASTRITIS

Tipo de Herida: SUCIA **Tipo de Anestesia:** SEDACION **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 09:40:00 **Hora Final** 10:05:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: ERGE
SE INTRODUCE GASTROSCOPIO OLYMPUS
ESOFAGO:MUCOSA NORMAL ,PASO FÁCIL POR EL CRICOFARINGEO, PERISTALTISMO,
VASCULARIDAD,CONSERVADOS, LINEA A 37 NO COINCIDE CON LA IMPRESIÓN HIATAL QUE SE ENCUENTRA A 41 CM .
ESTOMAGO: EXPLORADO HASTA PÍLORO INCLUYENDO RETROVISIÓN PARA PEQUEÑA CURVA Y FONDO GÁSTRICO NORMALES.
MUCOSA DE CUERPO SIN ALTERACIONES. ANTRO CON EROSIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO EN REGION PREPILORICA.
PILORO FRANQUEABLE.
DUODENO: NORMAL HASTA SEGUNDA PORCIÓN
BIOPSIAS:FRASCO 1: ANTRO
***CONCLUSION:
1.HERNIA HIATAL TIPO I
GASTRITIS CORPORO ANTRAL EROSIVA MODERADA
Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :
PROCEDIMIENTO BAJO SEDACIÓN ANESTESIOLOGA DRA RODRIGUEZ (FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL).
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE
REALIZADO POR JEISSON HINCAPIE
COLONOSCOPIA TOTAL
***INDICACIÓN: DOLOR ABDOMINAL
SE INTRODUCE COLONOSCOPIO OLYMPUS
INSPECCIÓN: NO ORIFICIOS FISTULOSOS, NO FISURAS, NO HEMORROIDES EXTERNAS, NO PLIEGUES CUTANEOS REDUNDANTES.
TACTO RECTAL: ESFINTER NORMOTONICO, NO MASAS PALPABLES, DEDO DE GUANTE SALE LIMPIO.
ANOSCOPIA: CANAL ANAL SIN ALTERACIONES, LINEA DENTADA DE CONFORMACION HABITUAL, AMPOLLA RECTAL VACIA SIN LESIONES MUCOSAS, RETROFLEXION SIN HEMORROIDES INTERNAS.
COLONOSCOPIA: SE AVANZA HASTA ANGULO HEPATICO DEL COLON DE DONDE NO LOGRAMOS AVANZAR POR PRESENCIA DE

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

HERNIA INGUNO ESCROTAL IZQUIERDA EN LA CUAL COMO CONTENIDO HERNIARIO,TIENE GRAN PARTE DEL COLON SIGMOIDES, APESAR DE MULTIPLES INTENTOS DE RECTIFICACION EL COLONO SIEMPRE SE ANGULA Y FORMA ASA DENTRO DE LA HERNIA, LAS AREAS EXPLORADAS SIN LESIONES. PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES APARENTES. PREPARACIÓN BOSTON CD: 3, CT: 3, CI: 3
9/9.
***CONCLUSIÓN:
1. COLONOSCOPIA HASTA ANGULO HEPATICO DEL COLON SIN LESIONES

Tejidos enviados a patología : SI [X] **NO** [ ]

BIOPSIAS:FRASCO 1: ANTRO

JEISSON DAVID HINCAPIE ALVAREZ
Reg. 1115066530
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

***** FIN DEL REPORTE *****